

CareConnect – Einführung eines Patientenportals

Projektnummer: 76829
Projektmanager/in: Marz, Steffen Helmut
Projektart: IT Projekt, Strategieprojekt

1) WO stehen wir? → Ausgangssituation und Projektkontext

Ausgangssituation / Projektkontext:

Das Krankenhaus verfolgt das Ziel, sich als modernes, patientenzentriertes Gesundheitszentrum zu etablieren. Hierbei wird die Digitalisierung als strategisches Instrument gesehen, um interne Prozesse zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Des Weiteren wird sich durch die Einführung eines Patientenportals eine Steigerung der Patientenzufriedenheit erhofft.

Aktuelle Herausforderungen bei denen das Patientenportal unterstützen soll:

- Einige administrative Aufgaben, wie die präoperative Anamnese oder das Terminmanagement werden aktuell manuell durchgeführt, was zu Verzögerungen sowie einem hohen Arbeitsaufwand führt.
- Die Kommunikation zwischen Patienten und medizinischem Personal erfolgt überwiegend über Papier oder Telefon was zeitaufwändig und fehleranfällig ist.
- Patienten haben aktuell keine Möglichkeit, ihre Daten selbstständig einzusehen und zu verwalten. Zudem können Sie sich nicht aktiv in den Behandlungsprozess einbringen.

Das Krankenhaus hat in mehreren Auswahlstufen bereits die passende Software „Care Connect“ (fiktiv) identifiziert und ein Agreement mit dem Anbieter getroffen. Der nächste Schritt ist die Integration von Care Connect in die bestehende IT-Infrastruktur sowie in die Prozesse.

Das Krankenhaus hat mehrere IT Systeme (KIS, RIS, LIS, PACS) welche über einen Kommunikationsserver (Mirth Connect) miteinander verbunden sind.

Kundenanforderungen:

Anforderungen aus Sicht des Krankenhauses:

- Integration des Portals in die bestehende IT-Infrastruktur
- DSGVO Konformität
- Bereitstellung von mehreren Funktionen wie präoperative Anamnese, Terminmanagement, Ärzte-Patienten Kommunikation und Feedbackmöglichkeiten.
- Intuitive Bedienung für Patienten aller Altersgruppen und Technikaffinität, klares Onboarding auch in der App und nicht nur vor Ort.
- Schulungsmaterial für Mitarbeiter sowie Patienten
- Schulung der speziellen Mitarbeiter und der IT-Abteilung
- Aktives Change-Management zur Förderung der Akzeptanz bei Mitarbeitern
- Unterstützung im Change-Management zur Förderung der Akzeptanz bei Patienten

2) WARUM? → Wirkungen, Nutzen und Strategierelevanz	
Wirkungen / Projektnutzen / Strategierelevanz:	Verbesserte Patientenkommunikation und Zufriedenheit: - Durch eine benutzerfreundliche Plattform erhalten Patienten die Möglichkeit aktiver in den Behandlungsprozess einbezogen zu werden. Sie können aktiv medizinische Daten verwalten (begrenzt) und einsehen, Termine organisieren und direkt mit medizinischem Personal kommunizieren. - Hierdurch entstehen eine verstärkte Transparenz und eine Verringerung von Wartezeiten und Missverständnissen. Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung - Administrative Prozesse wie präoperative Anamnese und Terminmanagement werden digitalisiert und automatisiert. - Hierdurch können Fehlerquellen reduziert und Personal entlastet werden. - Papierdokumente werden reduziert und Terminpläne können effizienter erstellt werden. Dies sorgt bei guter Planung für eine bessere Ressourcennutzung. Strategische Positionierung als Vorreiter - Durch die Einführung eines modernen Patientenportals positioniert sich das Krankenhaus als Vorreiter in diesem Bereich. Patientenportale verbreiten sich zwar immer mehr, sind aber noch nicht vollständig bei den Patienten angekommen. Langfristige Kosteneinsparungen - Die Digitalisierung sowie Automatisierung von Prozessen führen langfristig zu einer Reduzierung der Betriebskosten. - Es wird an Papier und manueller Arbeit eingespart, während Fehlerkosten durch automatisierte Abläufe reduziert werden.

3) WAS soll konkret erreicht werden? → Ziele und Inhalte	
Projektgesamtziel:	Das Ziel des Projekts ist die erfolgreiche Einführung des Patientenportals "Care Connect" im Krankenhaus, um die Patientenkommunikation und -interaktion zu verbessern, administrative Prozesse zu optimieren und die Patientenzufriedenheit zu steigern. Das Portal soll nahtlos in die bestehende IT-Infrastruktur integriert werden und die gesetzlichen Anforderungen (z. B. DSGVO) erfüllen.
Teilziele →	Messbare Ergebnisse
Integration des Patientenportals in die IT-Infrastruktur	Erfolgreiche Anbindung des Portals an das KIS, RIS, LIS sowie das PACS. Behandlungsdaten sowie Termine aus den verschiedenen Systemen sowie Bilder aus dem PACS können im Patientenportal angezeigt werden. Interoperabilität folgt dem FHIR-Standard. Bietet ein System diesen Standard nicht, werden HL7v2 Nachrichten über den Kommunikationsserver transformiert.
Schulung und Akzeptanzförderung bei Mitarbeitern	Erstellung und Verteilung von Schulungsmaterial für alle Mitarbeiter. Durchführung von mindestens 7 Schulungsworkshops für Key User mit einer Schulungsbeteiligung von mindestens 90%.

Optimierung interner Prozesse	- Reduzierung der Bearbeitungszeit präoperativer Anamnesen um 20% innerhalb der ersten 3 Monate, um 40% innerhalb der ersten 6 Monate nach Einführung. - Teilautomatisierung vom Terminmanagement (nur Kontrolle durch Mitarbeiter nötig) - Automatisierung des Feedbackprozesses.
Sicherstellung der Einhaltung von Datenschutz und Sicherheitsstandards	- Erstellung eines Datenschutzkonzeptes sowie DSGVO Audit - Regelmäßige Durchführung von 6 Sicherheits- sowie Penetrationstest / Monat mit erfolgreichem Abschluss. Im ersten Monat 4 / Woche. - Implementierung von Verschlüsselung- und Authentifizierungsmechanismen nach der ISO31000er Gruppe
Steigerung der Patientenzufriedenheit	- Zufriedenheit mit dem Portal von über 80%, 6 Monate nach der Einführung. (z.B. Messung durch Umfragen) - Allgemeine Steigerung der Gesamtzufriedenheit der Patienten - Aktive Nutzung von durch mindestens 40% der Patienten im ersten Jahr, aktive Steigerung.
Nicht-Ziele / Nicht-Inhalte:	- Entwicklung der Software - Integration in externe Systeme (z.B. ELGA) - Langfristige Wartung und Updates - Erweiterungen oder neue Funktionen
Projektrisiken:	- <Qualitätsrisiken> - Unzureichende Tests - Mangelhafte Schulung - <technische Risiken> - Integrationsschwierigkeiten - Sicherheitslücken - <Auslastungsrisiken> - Überlastung der IT-Abteilung - Nicht genug Schulungspersonal - Fehlende Zeit der Key User zur Schulung restlicher Nutzer - <Terminrisiken> - Nur eine Steigerung der durch Verzögerung entstandenen Kosten. Betrieb läuft auch ohne Portal weiter. - Verzögerung könnte jedoch für Unmut sorgen. - <Akzeptanzrisiken> - Widerstand von Mitarbeitern oder Patienten gegen die Nutzung des Portals - Geringe Nutzung des Patientenportals durch nicht technikaffine Nutzer - Weiteres: - Änderungen gesetzlicher Vorgaben während des Projektes - Unvorhergesehen Kosten für z.B. benötigte Anpassungen an bestehenden Systemen.

Gegenmaßnahmen:	Qualitätsrisiken: - Umfassender Testplan - Integrationstest - Wenn nötig, Einbindung von externen Experten (! Kosten) - Entwicklung benutzerfreundlicher Schulungsmaterialien (durch Hersteller) - Entwicklung barrierefreier Schulungsmaterialien (durch Hersteller) Technische Risiken: - Analyse der bestehenden IT-Infrastruktur - Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen nach ISO 31000 - Durchführung von Sicherheits- und Penetrationstests von externen Experten. Auslastungsrisiken: - Einbindung externer Dienstleister oder des Herstellers, um interne IT-Mitarbeiter zu entlasten - Regelmäßige Abstimmung im Projektteam, um Ressourcenengpässe rechtzeitig erkennen und Aufgaben dann korrekt priorisieren und umverteilen zu können. - Einsatz von externen Ausbildern (z.B. von Hersteller) - Schulung von Key Usern die das Wissen intern weitergeben (Multiplier Effekt) - Mehrphasige Schulung, nicht alles in 1 Woche. Terminrisiken: - Detaillierter Projektplan - Klare Meilensteine und Pufferzeiten - Statusupdates und Fortschrittskontrollen durch das Projektmanagement - Klar definieren, was bei welcher Verzögerung an welche Person weitergegeben wird, also wie was Eskaliert wird. - Testen des Portals in einer Pilotphase Akzeptanzrisiken: - Durchführung von Informationsveranstaltungen - Einbeziehung der Stake Holder - Bereitstellung von Support - Schulungen für nicht-technikaffine Nutzer - Barrierefreie Plattform Weiteres: - Einbindung von Datenschutzexperten und regelmäßige Überprüfung auf rechtliche Änderungen. - Regelmäßige Plan-Ist Kontrolle mit Berichterstattung an Projektleitung.
-----------------	--

4) WER ist involviert? → Projektorganisation			
Projektleiter/in:	Steffen Marz	Projektauftraggeber/in:	Krankenhaus XY
Projektteammitglieder:		Projektlenkungs- ausschuss: ☐ Ja ☐ Nein	?

Projektkunde:	Krankenhaus XY Projektentscheider/in Kunde: Max Mustermann Projektmanager/in Kunde: Maria Musterfrau
Sonstige Beteiligte:	?

5) WIE können die Ziele erreicht werden? → Projektstruktur

Teil-/Hauptaufgaben → Arbeitspakete

Analyse der bestehenden IT-Infrastruktur	- Bestandsaufnahme der bestehenden Pakete - Identifikation der Schnittstellen - Analyse der rechtlichen Anforderungen - Erstellung eines Anforderung Katalogs
Planung und Konzeption der Integration	- Entwicklung eines Integrationsplans - Erstellung eines Testplans - Definition von KPIs zur Erfolg Messung
Technische Integration & Tests	- Anbindung des Portals an bestehende Systeme - Durchführung von Integration und Penetrationstests - Pilotphase
Schulung und Einführung	- (Schulung der Key User geschieht schon in der Pilotphase, Lehrmaterial wird früher bereitgestellt.) - Sammeln von Feedback - Schulungen für medizinisches Personal - Rollout in allen Abteilungen
Evaluierung	- Analyse der Nutzerstatistiken, Nutzerfehler etc. - Durchführung von Umfragen - Berichterstellung - Planung und Übergabe der Wartung

6) Bis WANN? → Meilensteine und Termine

Projektstart:	?	Projektende:	?
Projektstartereignis:	Anforderungsanalyse	Projektendereignis:	Übergabe an Wartung
Meilensteine:	1. Einführung zur Testung 2. Erfolgreiches Pilotprojekt 3. Go-Live 4. Erfolgreicher Übergang in die Wartung -> Projektabschluss (Kriterien fehlen hier noch, sollen da dann KPIs hin oder so etwas wie ein Prozentsatz in der Zufriedenheit der Mitarbeiter o.ä.?)		

Zu den genauen Daten habe ich noch nicht so ganz eine Idee. Ich gehe von ca. 1- 1.5 Jahren von Analyse, Schulung, Go-Live bis zur Übergabe an die Wartung aus.

7) WIEVIEL? → Projektbudget und Wirtschaftlichkeit

Hier bin ich aktuell noch komplett verloren und müsste irgendwas erfinden, daher habe ich das noch ausgelassen.

Personalaufwand:	<Beteiligte + Aufwand in Tagen / Wochen>
-------------------------	--

Summe Personalaufwand:	<Summe in €, Personalaufwand mal interne Verrechnungssätze>	
Externe Aufwände:	<z.B. ext. Dienstleistungen>	<in €>
		<in €>
		<in €>
Sonstige Ressourcen:	<z.B. Maschinen, Labors, Räume>	
Gesamtaufwand / Projektbudget:	<in €>	
Projekteinnahmen / Wirtschaftlichkeit:	<Sind während des Projekts / nach Beendigung des Projekts Einnahmen zu erwarten?>	
Folgekosten nach Beendigung des Projekts:	<Entstehen Folgekosten, die bereits jetzt bekannt sind?>	

8) Kommunikation / Berichtswesen / Sonstiges

Hier bin ich aktuell noch komplett verloren und müsste irgendwas erfinden, daher habe ich das noch ausgelassen.

Was? (Inhalt)	Wie? (Medium)	Wer? (Verantwortung)	An wen? (Zielgruppe / Adressat)	Wann? Wie oft? (Zeitpunkt / Wiederholung)
Sonstige relevante Informationen:				

Projektentscheidung:	☐ Das Projekt wird frei gegeben.
	☐ Der Projektauftrag soll überarbeitet werden.
	Änderungen:
	☐ Das Projekt wird abgelehnt.
	Begründung:
	
	<Datum> <Datum>
	<Auftraggeber/in> <Projektleiter/in>